EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 81191
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-03-22 14:06:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: BERTA DEL CARMEN SALVO GoMEZ			**RUN**	: 5.707.586-4
F.Nac	: 01-05-1940	**Edad**	: 83 AÑOS, 10 MESES	**Género**	: Femenino
Dirección	: BULI ORIENTE			**Comuna**	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	**Teléfono**	: 975461880		
Fecha Ingreso	: 2024-03-22	**Fecha Egreso**	: 2024-03-22 14:06:00	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: DOMICILIO	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I64.X-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO NO ESPECIF.COMO HEMORRAG

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

-Infartos isquémicos agudos tálamo capsular y corticales fronto-parieto-temporal derechos
-FA sin TACO
-Hipertiroidismo

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I63-INFARTO CEREBRAL (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Antecedentes:
-Enf: HTA, artrosis, fibrosis pulmonar, ca mama izquierda en HT (2 años)
-Fcos: atenolol 25 mg c/12h, FSD 20 mg/d, metildopa 125 mg/d, ATV 20 mg/n, omeprazol 20 mg/d, ipratropio 2 puff c/12h
-Alergia(-)
-Qx: prolapso vaginal, hernia inguinal izq
-OH(-) Tabaco(-) Drogas(-)
-mRS 1

Historia clínica
El 16/3 a las 23h presentó caída a nivel, hemiparesia BC izq y disartria. Consultó en SU HSC, se detectó FA y se derivó a domicilio. Cardiólogo en extrasistema solicitó RM cerebro que muestra infartos corticales fronto-temporo-parietales y talamocapsular derechos agudos/subagudos, sin TH, posible infarto antiguo cortical occipital izq. Se hospitaliza para evaluación y manejo. Al ingreso en FA s/RVR, BEG, no refiere molestias, hemiparesia izquierda en regresión progresiva espontánea (BC M4+) y disartria leve. Se hospitaliza para evaluación y manejo.

Evolución
Paciente BEG, HDN estable, FA al monitor, afebril, eupneica, tolera bien alimentación VO, Fonoaudiología descartó disfagia significativa, estable en déficit neurológico, no refiere molestias. Sin antecedentes de HDA o sd ulceroso no controlado.
AngioTC cerebro y cuello no muestra estenosis significativas, sin TH en lesiónes isquémicas subagudas conocidas.
Exs de lab destaca hiponatremia e hipokalemia leves (Na 133, K 3.3) y alteración de pruebas

tiroideas compatible con hipertiroidismo. Se conversa caso con Dra Quijada para iniciar tiamazol 10 mg/d, solicitar ecotomografía tiroidea, TRAB y control en policlínico de Medicina Interna en 2 semanas.
Decido inicio de TACO.
ETT informa FEVI 38%, hipocinesia difusa y megaurículas.
En vista de la estabilidad se decide alta a domicilio y control ambulatorio en policlínico de Neurología.

PLAN DE MANEJO:

-Alta a domicilio hoy
-Reiniciar tto crónico
-TRAB hoy
-Ecotomografía tiroidea
-Control en policlínico de Medicina Interna en 2 semanas con hemograma, hoja hepática, TSH y T4L
-Control en policlínico de Neurología en 10-12 días

INDICACIONES AL ALTA

1. -Apixaban 2.5 mg c/12h
2. -Omeprazol 20 mg/día
3. -Atorvastatina 40 mg/noche
4. -Tamsulosina 0.4 mg/noche solo en caso de retención urinaria
5. -Tiamazol 10 mg/día

EXÁMENES Y RESULTADOS

TC tórax (21/3/24): enfisema pulmonar centrolobulillar, lesiones quísticas en bases pulmonares en contexto de enfermedad pulmonar intersticial linfoidea (no se descartan otros procesos), engrosamientos peribronquiales compatibles con inflamacion aguda y/o crónica de la vía aérea con tapones mucosos en ambas bases pulmonares, cardiomegalia global con ateromatosis aórtica y coronaria.

22/3/24
-TSH 0.328 T4L 1.87 Anti-TPO 1.2

21/3/24
-Glic 106 Hb glic 5.6
-Crea 0.8 MDRD 68.5 Uremia 84
-AU 9.1
-Ca 9
-FA 95 BI 0.99 BD 0.11 BT 1.1 GOT 38 GPT 24 GGT 42
-CKMB 107 CK 187
-ColT 189 HDL 54 LDL 110 VLDL 24.8 TG 124
-LDH 234
-PCR 7.4
-OC N
-Na 133 K 3.3 Cl 92
-Hb 14.7 Leu 6100 Plaq 187000 Seg 70
-INR 1.13 TTPA 27
-Trop 34.9
-TSH 0.313 T4L 1.79
-B12 544
-RPR N/R

OBSERVACIONES:

Ex fco gral
-Perfusión e hidratación N, yug no ing, rash(-)

-Cardiaco: RR 2T s/s
-Pulmonar: MP(+) SRA
-Abd: BDI, RHA(+) no palpo masas
-EE: edema(-), TVP(-), pulsos+/+

Ex neurológico:
-Mental: conservado
-PC: CV normal, pupilas medias e isocóricas, RFM D/C +/+, MOE N, PFC izq minima, disartria leve, nistagmo(-), pares bajos N
-Motor: fuerza M5 BC der y M4+ BC izq, RCP extensor izq y flexor derecho
-Sensitivo: conservado
-Cerebelo: dismetría leve BC izq proporcional a paresia, resto conservado
-Signos meningeos(-)

Saulo Venegas Figueroa
MEDICO TRATANTE
16138950-1

JEFE SERVICIO